

Lorena, SP, 17 de Fevereiro de 2022.

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES

Artigo 155, Inciso VII – Instrução 01/2020

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Lorena, CNPJ nº 51.779.304/0001-30, por meio do convênio 350/2020, recebeu no ano de 2021 em parcelas mensais o valor total de **R\$. 2.381.928,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais)**, destinados para o objeto do convênio, **Custeio de Hospital Estratégico - Material de Consumo e Despesas com Serviços de Terceiros, referente ao “Programa Santa Casas Sustentáveis”**. Este repasse foi utilizado parcialmente no exercício de 2021 para aquisição de materiais hospitalares, medicamentos, lavanderia, bem como para o pagamento de serviços de terceiros inclusive médicos, auxiliando financeiramente a instituição, contribuindo para o desenvolvimento de um parque hospitalar de referência necessidades população regional, capaz de prestar serviços de média complexidade, atendendo as demandas e, conforme plano de trabalho estabelecido, sendo aplicado da seguinte forma:

Comparativo de Metas:

Plano de trabalho:

- 1 - Manter 100% do CNES atualizado;
- 2 - Manter os Diagnósticos secundários preenchidos nas AIH acima de 25%, discriminados por clínicas: pediatria, ginecologia, médica e cirúrgica e enviar relatório ao município para que este atualize as informações a DRS;
- 3 - Atualizar diariamente, no Portal CROSS, das informações dos recursos disponíveis para atendimentos às urgências;
- 4 - Manter os atendimentos de urgência e emergência referenciado, mediado pela Central de Regulação, nas 24 h nos 07 dias da semana;
- 5 - Atualizar diariamente, no Portal CROSS, da ocupação dos leitos hospitalares;
- 6 - Atualizar diariamente, no Portal CROSS, no modulo ambulatorial de recepção dos pacientes agendados;
- 7 - Disponibilização mensal de agenda ambulatorial no portal Cross;
- 8 - Protocolo de Acolhimento e de Classificação de Risco;
- 9 - Alta Hospitalar qualificada;
- 10 - Implementar o Custos por Absorção;
- 11 - Implantar a Política estadual de humanização;
- 12 - Apresentar as Contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da AIH (alta hospitalar) com antecedência ao município para que esta possa repassar as informações à DRS;
- 13 - Apresentar as contas ambulatoriais no mês imediato à realização do procedimento com antecedência ao município para que esta possa repassar as informações à DRS;
- 14 - Disponibilizar as caracterizações correta da internação: AIH de urgência (caráter 2 à 6) / AIH eletiva (caráter 1) - por amostragem;
- 15 - Apresentar relatório das Comissões, definindo avaliações realizadas e recomendações;
- 16 - Apresentar relatório da Comissão Intra hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes à Central de Transplantes da SES na data estabelecida;
- 17 - Implantar o Plano de atendimento a desastres e incidentes com múltiplas vítimas;
- 18 - Apresentar os Alvarás de funcionamento e auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB);
- 19 - Manter a taxa de suspensão de cirurgia por motivos administrativos dentro da meta estabelecida (meta 2%, exceto cirurgias ambulatoriais);
- 20 - Manter a taxa de recusa de solicitação dentro dos padrões aceitáveis sempre que possível 10%;
- 21 - Acompanhar o Percentual de Vaga Zero junto ao CROSS e aceitar 10% das vagas zeros;



- 22 - Apresentar os relatórios de Educação permanente do estabelecimento, contendo as capacitações e treinamentos realizados no período;
23 - Apresentar o Balanço Patrimonial e Declaração da Análise Econômica e financeira referente ao ano anterior;
24 - Apresentar a Relação enfermeiro leito;
25 - Manter a taxa de alcance da produção conveniada/contratada em 72,73%, categoria hospitalar, especialidades cirúrgicas 90, Obstétricas 111, clínica médica 174 e clínica pediátrica 38;
26 - Manter a taxa de ocupação dos leitos SUS entre 60% e 70%;
27 - Aumentar taxa de ocupação leitos terapia intensiva adulto para 90%;;
28 - Manter tempo médio de permanência – na especialidade clínica em 07 dias;
29 - Manter tempo médio de permanência – na especialidade cirúrgica em 07 dias;.
30 - Manter tempo médio de permanência – UTI adulto em 07 dias
31 - Reduzir a taxa de mortalidade institucional para 3%, devido ao perfil demográfico da região;
32 - Enviar relatório com indicadores de infecção hospitalar ao município para que esta possa informar índices à DRS;
33 - Reduzir a incidência de queda de paciente para abaixo de 2%;
34 - Informar índice de rotatividade SUS;
35 - Informar índice de uso de sala cirúrgica, manter ocupação em 60%.

Resultados Alcançados: Em 2021 por causa do estado de calamidade pública em razão da Pandemia pelo vírus COVID-19, não conseguimos atingir as metas pactuadas. Ressalta-se, todavia, a publicação da Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021 que suspendeu, até 31/12/2021, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas estabelecidas com os hospitais filantrópicos contratualizados com o SUS.

ITEM	Descrição (meta, ação, manutenção)	Custeadas c/ T.A. R\$	Custeadas c/ Rec Próprio R\$
1	Manutenção Serviços de Terceiros	R\$ 173.873,40	0,00
2	Manutenção Materiais Hospitalares	R\$ 290.115,02	0,00
3	Manutenção Serviços Médicos	R\$ 1.237.803,99	0,00
4	Manutenção Medicamentos	R\$ 471.946,25	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO T.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
R\$ 2.391.652,09	R\$ 969,14	R\$ 2.392.621,23	R\$ 1.082,29	R\$ 2.393.703,52

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

MARIO TEIXEIRA DA SILVA:51479753815

Assinado de forma digital por MARIO TEIXEIRA DA
SILVA:51479753815
Dados: 2022.02.17 08:27:44 -03'00'

Mario Teixeira da Silva
Provedor

